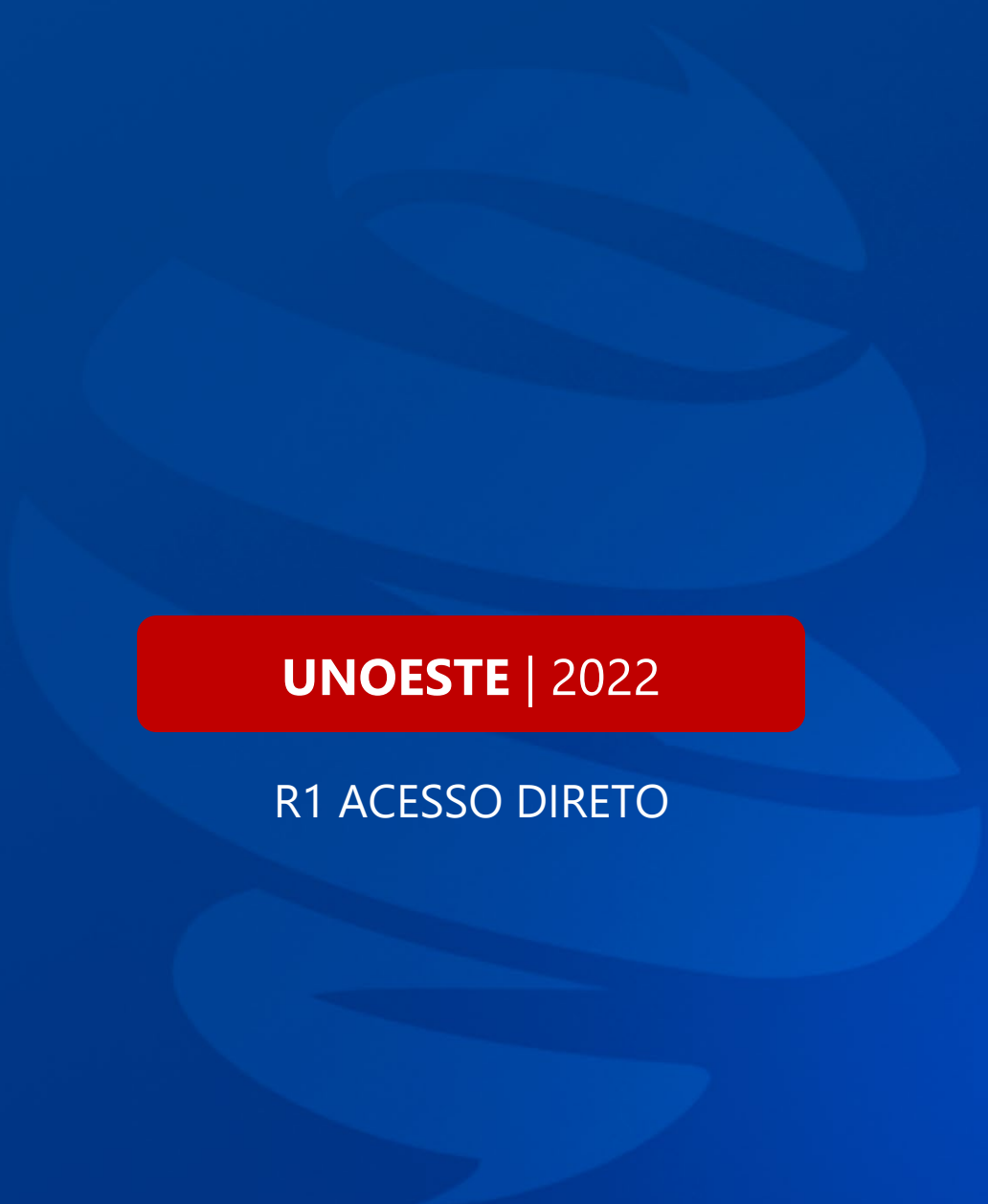




UNOESTE | 2022

R1 ACESSO DIRETO

1) Paciente do sexo masculino, 68 anos, com história de dispneia aos grandes esforços e tosse seca há vários anos, relata piora da dispneia e da tosse, que evoluiu para produtiva com secreção amarelada e febre há 48 horas. Apresenta antecedentes de tabagismo atual (01 maço/dia há 42 anos) e hipertensão arterial em uso de anti-hipertensivo (anlodipina 20 mg/dia). Ao exame físico: consciente e orientado, sem déficits cognitivo ou motor. Ritmo cardíaco regular sem sopros. Pressão arterial MSD: 124 x 88 mmHg pulso: 77 bpm. Murmúrio vesicular universalmente diminuído com estertores crepitantes do terço médio do hemitórax direito. Frequência respiratória: 23 irpm SatO₂: 93%aa. Abdome sem alterações. Edema de membros inferiores ++/4+, pulsos periféricos + simétricos isobáricos. Exames complementares: Hemograma: hemoglobina 14,8 mg/dL; leucócitos: 12300/mm³. Proteína C reativa 5,3 mg/dL (VN > 1 mg/dL). Ureia 43 mg/dL; creatinina 1,1 mg/dL. O exame complementar indicado para o quadro atual é:

- A) teste rápido pra SARS-CoV-2.
- B) hemocultura e cultura de orofaringe.
- C) marcadores de necrose miocárdica.
- D) dosagem de alfa1 antitripsina.
- E) radiografia de tórax.

2) Paciente do sexo masculino, 68 anos, com história de dispneia aos grandes esforços e tosse seca há vários anos, relata piora da dispneia e da tosse, que evoluiu para produtiva com secreção amarelada e febre há 48 horas. Apresenta antecedentes de tabagismo atual (01 maço/dia há 42 anos) e hipertensão arterial em uso de anti-hipertensivo (anlodipina 20 mg/dia). Ao exame físico: consciente e orientado, sem déficits cognitivo ou motor. Ritmo cardíaco regular sem sopros. Pressão arterial MSD: 124 x 88 mmHg pulso: 77 bpm. Murmúrio vesicular universalmente diminuído com estertores crepitantes do terço médio do hemitórax direito. Frequência respiratória: 23 irpm SatO₂: 93%aa. Abdome sem alterações. Edema de membros inferiores ++/4+, pulsos periféricos + simétricos isobáricos. Exames complementares: Hemograma: hemoglobina 14,8 mg/dL; leucócitos: 12300/mm³. Proteína C reativa 5,3 mg/dL (VN > 1 mg/dL). Ureia 43 mg/dL; creatinina 1,1 mg/dL. Na análise inicial desse paciente, segundo o critério CURB 65, esse perfil de pacientes apresenta

- A) alta mortalidade, aproximadamente 22%.
- B) baixa mortalidade, aproximadamente 1,5%.
- C) histórico de queixas respiratórias, elevando o risco de mortalidade.
- D) muito alto risco com mortalidade > 30%.
- E) idade > 65 anos e presença de comorbidade cardiovascular, classificado como risco moderado.

3) Paciente do sexo masculino, 68 anos, com história de dispneia aos grandes esforços e tosse seca há vários anos, relata piora da dispneia e da tosse, que evoluiu para produtiva com secreção amarelada e febre há 48 horas. Apresenta antecedentes de tabagismo atual (01 maço/dia há 42 anos) e hipertensão arterial em uso de anti-hipertensivo (anlodipina 20 mg/dia). Ao exame físico: consciente e orientado, sem déficits cognitivo ou motor. Ritmo cardíaco regular sem sopros. Pressão arterial MSD: 124 x 88 mmHg pulso: 77 bpm. Murmúrio vesicular universalmente diminuído com estertores crepitantes do terço médio do hemitórax direito. Frequência respiratória: 23 irpm SatO₂: 93%aa. Abdome sem alterações. Edema de membros inferiores ++/4+, pulsos periféricos + simétricos isobáricos. Exames complementares: Hemograma: hemoglobina 14,8 mg/dL; leucócitos: 12300/mm³. Proteína C reativa 5,3 mg/dL (VN > 1 mg/dL). Ureia 43 mg/dL; creatinina 1,1 mg/dL. Diante da hipótese diagnóstica, o tratamento mais adequado nesse momento é:

- A) alta hospitalar somente com diureticoterapia.
- B) internação hospitalar em unidade de terapia intensiva.
- C) alta hospitalar com antibioticoterapia empírica.
- D) internação hospitalar em enfermaria com antibioticoterapia de largo espectro.
- E) internação hospitalar com associação de antibioticoterapia e antifúngico.

4) Paciente de 34 anos, puérpera recente, com história de hipertensão arterial durante cirurgia de cesariana há 10 dias, evoluindo no pós-operatório imediato com persistência de níveis pressóricos elevados, obtendo alta hospitalar com três classes de anti-hipertensivos para controle pressórico. Durante a internação, foi repetido exames de investigação de gestose hipertensiva, com transaminases normais e proteinúria de 24 h menor 10 mg, similar aos níveis da vigésima semana de gestação. Nega hipertensão arterial durante toda a gestação atual ou antes de engravidar. Procura ambulatório de clínica médica para orientação e tratamento. Ao exame físico, apresentava PA = 138 x 85 mmHg, FC = 78 bpm e ausculta cardíaca normal. Realizou um eletrocardiograma de repouso que demonstrou ritmo sinusal e alterações inespecíficas difusas da repolarização ventricular. Diante da hipótese diagnóstica, qual exame complementar deve ser realizado nesse caso?

- A) Holter 24h.
- B) Teste ergométrico.
- C) Ultrassom doppler de artérias renais.
- D) Angiotomografia de artérias coronárias.
- E) Ultrassom doppler de artérias carótidas.

5) Paciente de 34 anos, puérpera recente, com história de hipertensão arterial durante cirurgia de cesariana há 10 dias, evoluindo no pós-operatório imediato com persistência de níveis pressóricos elevados, obtendo alta hospitalar com três classes de anti- hipertensivos para controle pressórico. Durante a internação, foi repetido exames de investigação de gestose hipertensiva, com transaminases normais e proteinúria de 24 h menor 10 mg, similar aos níveis da vigésima semana de gestação. Nega hipertensão arterial durante toda a gestação atual ou antes de engravidar. Procura ambulatório de clínica médica para orientação e tratamento. Ao exame físico, apresentava PA = 138 x 85 mmHg, FC = 78 bpm e ausculta cardíaca normal. Realizou um eletrocardiograma de repouso que demonstrou ritmo sinusal e alterações inespecíficas difusas da repolarização ventricular. Assinale a alternativa que apresenta a estratégia terapêutica anti-hipertensiva segura para o lactente, segundo as diretrizes brasileiras atuais.

- A) Telmisartana.
- B) Sacubitril + valsartana.
- C) Prazosina.
- D) Hidralazina.
- E) Finerinona.

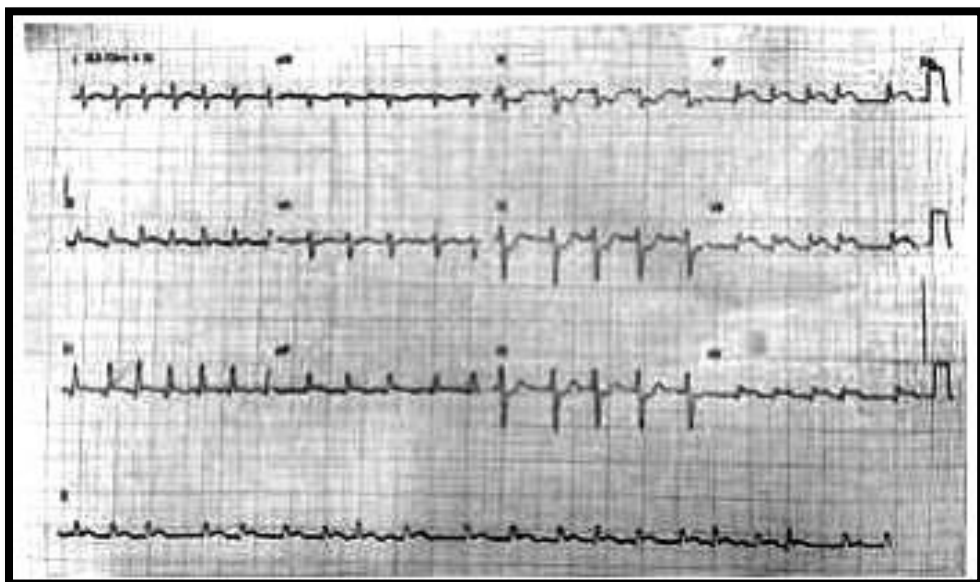
6) Na descoberta de um nódulo tireoidiano palpável em uma paciente assintomática, qual conduta deve ser realizada?

- A) Solicitar cintilografia de tireoide.
- B) Solicitar ressonância magnética cervical.
- C) Encaminhar para cirurgia de cabeça e pescoço.
- D) Solicitar TSH e ultrassom de tireoide.
- E) Encaminhar para punção por agulha fina.

7) Na artrite reumatoide, o exame complementar com maior sensibilidade e especificidade é:

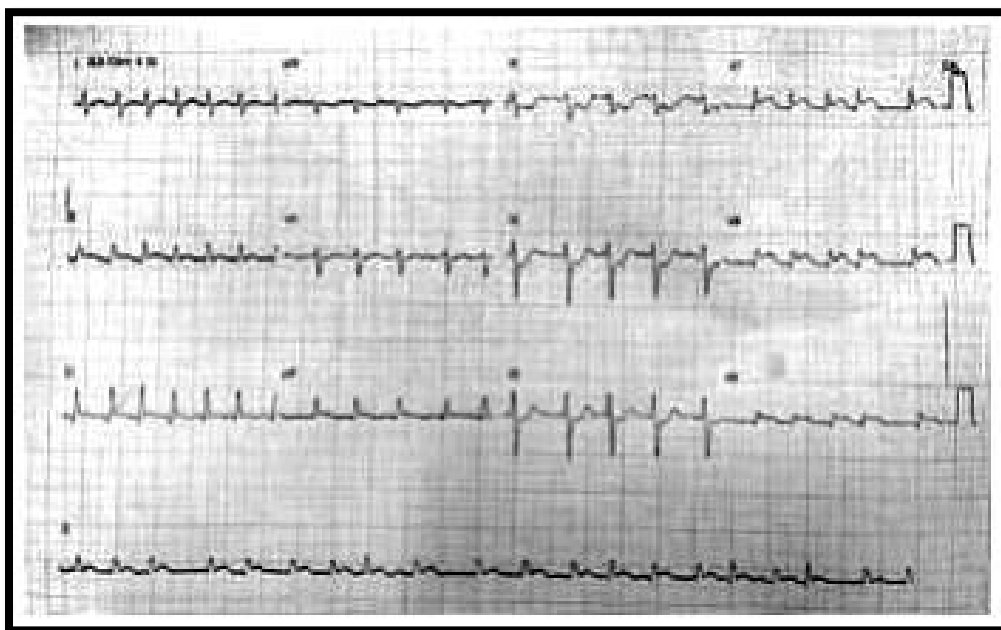
- A) fator reumatoide.
- B) velocidade de hemossedimentação.
- C) anticorpo antipeptídeo citrulinado cíclico.
- D) fator antinuclear.
- E) complemento sérico.

8) Paciente de 58 anos, sexo masculino, portador de fibrilação atrial paroxística, hipertensão arterial sistêmica estágio 2, hipercolesterolemia isolada, obeso e sedentário. Apresenta episódio de dor torácica de início em repouso há 30 minutos, com irradiação para o dorso, associado a palpitações e sudorese. Chega ao pronto atendimento da UPA em zona rural e realiza o eletrocardiograma de repouso a seguir. Segundo as diretrizes nacionais e internacionais, a conduta primordial para o caso clínico é:



- A) encaminhamento para um hospital terciário em até 6 horas.
- B) administração de fibrinolítico endovenoso.
- C) administração de heparina de baixo peso molecular endovenosa.
- D) encaminhamento a hospital terciário para a realização de angiotomografia.
- E) encaminhamento para realização de ecocardiograma transesofágico e cardioversão elétrica.

9) Paciente de 58 anos, sexo masculino, portador de fibrilação atrial paroxística, hipertensão arterial sistêmica estágio 2, hipercolesterolemia isolada, obeso e sedentário. Apresenta episódio de dor torácica de início em repouso há 30 minutos, com irradiação para o dorso, associado a palpitações e sudorese. Chega ao pronto atendimento da UPA em zona rural e realiza o eletrocardiograma de repouso a seguir. No acompanhamento ambulatorial no pós-alta, qual dos medicamentos a seguir tem indicação de associação ao tratamento preconizado no caso clínico?



- A) Ácido acetilsalicílico 300 mg 1x/dia.
- B) Rivaroxabana 20 mg 1x/dia.
- C) Cilostazol 50 mg 1x/dia.
- D) Varfarina 5 mg 1x/dia.
- E) Atorvastatina 80 mg 1x/dia.

10) As diretrizes atuais recomendam o rastreamento para a prevenção do câncer colorretal em indivíduos assintomáticos < 45 anos com história familiar em caso de

- A) intolerância a glúten ou doença celíaca.
- B) parente de primeiro grau com adenoma.
- C) doença inflamatória intestinal.
- D) câncer não gastrointestinal.
- E) síndrome de Lynch.

11) Paciente do sexo masculino, 42 anos de idade, com história de disúria, hematúria e febre vespertina sem calafrios, de início há 7 dias. Como antecedentes prévios, relatava episódios de artralgia generalizada há 3 anos, com episódios de repetição de rouquidão e odinofagia. Realizou exames complementares que evidenciaram: hemoglobina de 9,8 mg/dL, hematócrito de 29%, anisocitose, leucograma e plaquetas normais, ureia 190 mg/dL e creatinina sérica de 8,7 mg/dL. Urina 1 com 3+ de proteína, 4+ de hemoglobina, incontáveis hemácias, depósitos de uratos amorfos (++) , cilindros granulosos grossos e presença de corpos ovais e proteinúria de 24 h foi de 3750 mg. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) nefrolitíase.
- B) síndrome nefrítica.
- C) nefropatia por IgA.
- D) glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- E) síndrome nefrótica.

12) Paciente do sexo masculino, 42 anos de idade, com história de disúria, hematúria e febre vespertina sem calafrios, de início há 7 dias. Como antecedentes prévios, relatava episódios de artralgia generalizada há 3 anos, com episódios de repetição de rouquidão e odinofagia. Realizou exames complementares que evidenciaram: hemoglobina de 9,8 mg/dL, hematócrito de 29%, anisocitose, leucograma e plaquetas normais, ureia 190 mg/dL e creatinina sérica de 8,7 mg/dL. Urina 1 com 3+ de proteína, 4+ de hemoglobina, incontáveis hemácias, depósitos de uratos amorfos (++) , cilindros granulosos grossos e presença de corpos ovais e proteinúria de 24 h foi de 3750 mg. Durante a investigação do quadro clínico, foi solicitada a pesquisa do ANCA, cujo resultado foi positivo com padrão citoplasmático (c-ANCA), título de 1:40, e p-ANCA (perinuclear) negativo. Diante da hipótese diagnóstica, com base no exame complementar, o quadro etiológica da insuficiência renal aguda decorre de

- A) granulomatose de Wegener.
- B) síndrome de Churg-Strauss.

- C) poliarterite nodosa.
- D) vasculite leucocitoclástica cutânea.
- E) artrite reumatoide juvenil.

13) No atendimento a uma parada cardiorrespiratória, o fator inicial para diminuição de mortalidade é:

- A) intubação orotraqueal precoce.
- B) administração de adrenalina.
- C) compressão torácica efetiva.
- D) ventilação com máscara com reservatório.
- E) cardioversão elétrica.

14) No algoritmo de decisão para probabilidade de tromboembolismo pulmonar, qual o critério é encontrado no escore de Wells?

- A) Idade > 65 anos.
- B) Acidente vascular cerebral prévio.
- C) Pressão arterial sistólica > 100 mmHg.
- D) Hemoptise.
- E) Imobilização ou cirurgia ortopédica > 8 semanas.

15) Paciente do sexo masculino, 56 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia mista com história de artrite gotosa de repetição após ajuste terapêutico recente. O medicamento que tem maior correlação com esses episódios de repetição é:

- A) metformina.
- B) hidroclorotiazida.
- C) losartana potássica.
- D) empaglifozina.
- E) sinvastatina.

16) Na doença hepática gordurosa não alcoólica, a doença que tem correlação fisiopatológica associada é:

- A) Hepatite crônica pelo vírus A.
- B) Hipergonadismo.
- C) Hiperprolactinemia.
- D) Síndrome de ovários policísticos.
- E) Hipertireoidismo.

17) Assinale a alternativa que apresenta a doença que se encontra na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública do Ministério da Saúde, com indicação de notificação imediata, apesar da vacinação.

- A) Febre Amarela.
- B) Tétano.
- C) Hanseníase.
- D) Zika.
- E) Sífilis.

18) Paciente do sexo masculino, 51 anos, com história de gânglios na região cervical, indolores, aumentados, que incomodavam para dormir há 2 meses, evoluindo há 15 dias com queixa de dispneia aos esforços e piora progressiva. Submetido à biópsia de linfonodo cervical, qual achado histológico na anatomia patológica é compatível com a suspeita diagnóstica de linfoma?

- A) Linfócitos pleomórficos e basofílicos.
- B) Mielocitosazurófilos.
- C) Linfócitos com morfologia de células de Reed-Sternberg.
- D) Menor relação neutrófilo-linfócito.
- E) Linfócitos com morfologia de células de Leydig.

19) Paciente do sexo masculino, 51 anos, com história de gânglios na região cervical, indolores, aumentados, que incomodavam para dormir há 2 meses, evoluindo há 15 dias com queixa de dispneia aos esforços e piora progressiva. Durante a internação de um paciente, realizou-se a radiografia de tórax a seguir, submetido à toracocentese diagnóstica. O critério de Light que se correlaciona com a hipótese diagnóstica é:



- A) relação entre níveis proteicos do líquido pleural/soro $\leq 0,5$.
- B) glicose > 50 mg/dL no líquido pleural.

- C) proteína do líquido pleural < 1 g/dL.
- D) relação entre os níveis de LDH do líquido pleural soro > 0,6.
- E) presença de leucócitos totais < 250/mm³.

20) Um fator de risco para complicação de uma infecção urinária é:

- A) prolapso genital.
- B) diureticoterapia.
- C) enurese noturna.
- D) hipertensão arterial.
- E) espessamento vesical.

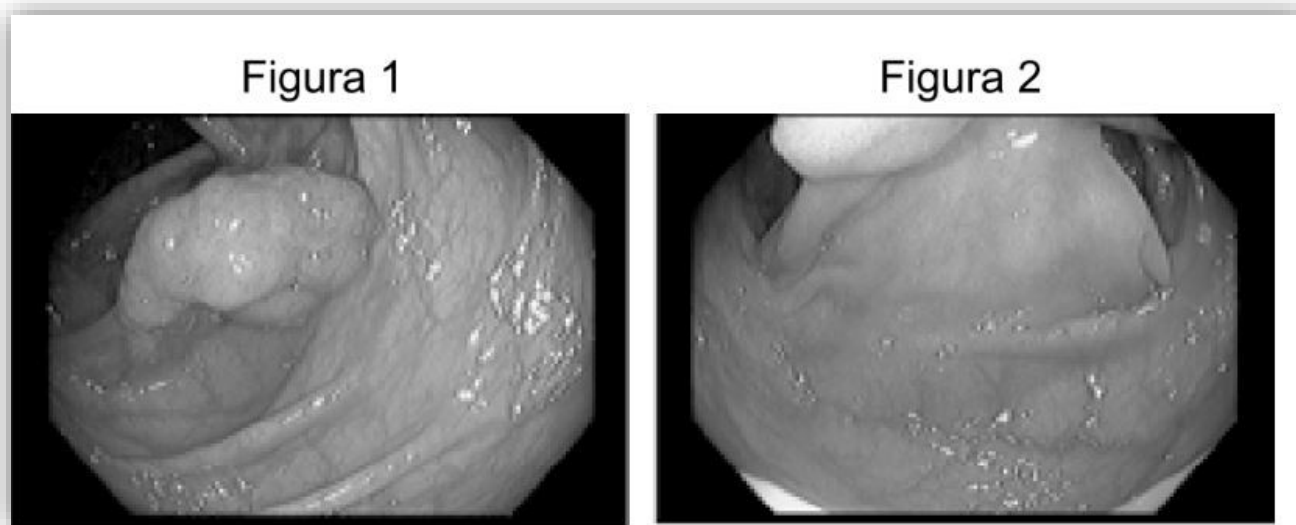
21) Homem de 19 anos deu entrada no pronto atendimento referindo perda de apetite e náuseas há 24 horas, evoluindo com dor periumbilical, a qual migrou para fossa ilíaca direita há cerca de 8 horas. Refere não ter aferido temperatura. Ao exame clínico, apresenta-se em bom estado geral, eupneico, anictérico e temperatura de 37,9 °C. Abdome plano, discreta rigidez, difusamente doloroso e com descompressão brusca + na fossa ilíaca direita (Ponto de McBurney). Ainda durante o exame físico do abdômen, ao se palpar a fossa ilíaca esquerda, o paciente referiu dor na fossa ilíaca direita. Quais são a principal hipótese diagnóstica e o nome desse último sinal clínico descrito?

- A) Apendicite aguda e Sinal do Obturador.
- B) Colecistite aguda e Sinal de Courvoisier Terrier.
- C) Colecistite aguda e Sinal de Murphy.
- D) Apendicite aguda e Sinal de Rovsing.
- E) Apendicite aguda e Sinal do Músculo Psoas.

22) Homem de 72 anos vem ao seu consultório referindo episódios de sangramento ao evacuar, de moderada quantidade, sem dor. Diz também já ter evidenciado alguns episódios de sangramento fora das evacuações. Todavia, nega perda de peso, dificuldade para evacuar ou qualquer sintoma de instabilidade hemodinâmica durante tais ocorridos. Nos antecedentes pessoais, relata ter tratado adenocarcinoma da próstata há 6 anos somente com radioterapia e fazer uso de ácido acetil salicílico (AAS) conforme recomendação do cardiologista. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, eupneico, anictérico e descorado +/4+. Ausculta pulmonar e cardíaca normais. Abdômen sem alterações. Toque retal indolor e com pequena quantidade de sangue na ampola retal. Diante do caso apresentado, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- A) Angiectasias do ceco.
- B) Retopatia actínica.
- C) Colopatia isquêmica.
- D) Neoplasia obstrutiva do cólon sigmoide.
- E) Doença inflamatório intestinal.

23) Mulher de 48 anos foi submetida à primeira colonoscopia para rastreamento do câncer colorretal. Nega perda de peso, dor abdominal ou alteração do hábito intestinal. No entanto, diz ter evidenciado algumas vezes a presença de sangue nas fezes. Pai com antecedente pessoal de pólipos do cólon e mãe falecida por neoplasia de reto. Durante a colonoscopia, identificou-se o seguinte achado no cólon sigmoide (Figuras 1 e 2). Quais são o diagnóstico e a conduta de escolha?



- A) Neoplasia obstrutiva do cólon sigmoide; retossigmoidectomia videolaparoscópica.
- B) Doença diverticular do cólon sigmoide; observação clínica.
- C) Pólipo do cólon sigmoide; quimioterapia.
- D) Pólipo do cólon sigmoide; polipectomia endoscópica.
- E) Linfoma do cólon sigmoide; quimioterapia.

24) Homem de 45 anos, obeso (IMC 40), portador de hipertensão arterial sistêmica, deu entrada ao pronto atendimento referindo ter sido vítima de ferimento por arma branca no abdômen, abaixo da cicatriz umbilical, há 40 minutos, decorrente de tentativa de assalto. Mostra-se lúcido, orientado e corado. Saturação de 95%, frequência cardíaca de 82 bpm e pressão arterial de 150 x 90 mmHg. Ao exame do abdômen, identificou-se ferimento de aproximadamente 3,0 cm de profundidade, com discreto sangramento em porejamento e hiperemia do local. Optou-se, então, pela realização do FAST, o qual foi negativo. Qual é a próxima conduta?

- A) Exploração digital da ferida.
- B) Tomografia do abdômen.
- C) Observação clínica.
- D) Laparotomia exploradora.
- E) Angiotomografia do abdômen.

25) Mulher de 33 anos foi vítima de atropelamento por automóvel na zona rural da cidade, há cerca de 30 minutos, e levada ao pronto atendimento por familiares. Ao exame clínico,

mostra-se confusa e agitada, frequência respiratória de 33 irpm, frequência cardíaca de 128 bpm e pressão arterial de 80 x 40 mmHg. Com o diagnóstico de choque hipovolêmico, a classificação com base nos parâmetros clínicos é:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

26) Qual é o principal agente etiológico da colite pseudomembranosa?

- A) *Clostridium difficile*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Staphylococcus bovis*.
- D) *Entamoeba histolytica*.
- E) *Helicobacter pylori*.

27) Homem de 62 anos diagnosticado com lesão de crescimento lateral granular (GLST) de 2,5 cm de diâmetro no cólon direito durante a primeira colonoscopia de rastreamento do câncer colorretal. Submetido à mucosectomia endoscópica em bloco, sem intercorrências, e encaminhado o espécime removido para exame anatomopatológico, o qual revelou tratar-se de adenocarcinoma intramucoso (estadiamento pTis), bem diferenciado e com margens livres de neoplasia. Diante do achado colonoscópico e histológico, qual é a conduta a ser adotada?

- A) Colectomia direita videolaparoscópica.
- B) Colectomia direita robótica.
- C) Colectomia total com reservatório ileal e ileostomia protetora.
- D) Colectomia total sem reservatório ileal e com ileostomia protetora.
- E) Acompanhamento por colonoscopia.

28) Qual é definição correta de retalho cutâneo?

- A) Tecido transferido ou transplantado que mantém seu pedículo vascular próprio.
- B) Tecido transferido ou transplantado sem sua circulação vascular intacta.
- C) Tecido somente transplantado no qual a circulação vascular faz-se unicamente pelo leito receptor.
- D) Tecido somente transferido em que a circulação vascular faz-se pelo leito receptor.
- E) Tecido transferido ou transplantado independentemente da sua circulação vascular.

29) Em relação às hipospadias, é correto afirmar:

- A) não há desenvolvimento incompleto da uretra.
- B) com base no posicionamento do meato uretral, a hipospadia mais frequente é a glandar.

- C) a uretrografia é essencial para o diagnóstico da hipospadia.
- D) todo paciente diagnosticado com hipospadia necessita de tratamento cirúrgico.
- E) nos casos de hipospadia perineal, não se faz necessário o diagnóstico diferencial com genitália ambígua.

30) Qual, entre as seguintes opções, é fator preditivo de intubação difícil?

- A) Abertura bucal de 4,5 cm.
- B) Distância esterno-mento de 14 cm.
- C) Mallampaty III.
- D) Distância tireomentoniana de 8 cm.
- E) Ausência do terceiro molar inferior bilateralmente (dentes do siso).

31) A respeito do câncer de tireoide, é CORRETO afirmar que:

- A) O carcinoma anaplásico é o mais agressivo deles.
- B) Os tumores bem diferenciados representam menos de 45% dos carcinomas.
- C) O carcinoma medular representa mais de 90% dos tumores da glândula tireoide.
- D) O carcinoma de células de Hurthle é uma variante do tumor medular da glândula tireoide.
- E) O carcinoma anaplásico da glândula tireoide é mais comum em mulheres jovens.

32) Homem de 27 anos, vítima de queda de motocicleta em alta velocidade, dá entrada no pronto atendimento dispneico, hipotenso, taquicárdico, cianótico e com turgência jugular. Ao exame, mostra-se com vias aéreas pervias, hemitórax esquerdo timpânico à percussão e com murmúrios vesiculares abolidos à ausculta. Nesse caso, qual deve ser a conduta imediata a ser tomada?

- A) Intubação orotraqueal com máscara laríngea.
- B) Traqueostomia percutânea.
- C) Drenagem do hemitórax direito.
- D) Toracocentese de alívio no hemitórax esquerdo.
- E) Radiografia de tórax.

33) Mulher de 72 anos refere "olho amarelo" e "urina escura" há 5 dias. Diz ter dor abdominal de leve intensidade e perda de 20 quilos em 4 meses. Nega febre. Realizou tomografia de abdômen, que revelou massa sólida de 5,0 cm de diâmetro na cabeça pancreática em íntimo contato com a veia porta, dilatação de 3,0 cm do ducto colédoco e linfonodo de 1,5 cm de diâmetro no tronco celíaco. Atualmente, qual é a conduta de escolha para confirmação diagnóstica?

- A) Ecoendoscopia com punção ecoguiada da massa pancreática.
- B) Endoscopia digestiva alta com visualização da papila duodenal maior.
- C) Enteroscopia por capsula endoscópica.

- D) Laparotomia exploradora.
- E) Cintilografia com Galio-67.

34) Em relação à onfalocese e à gastrosquise, é correto afirmar:

- A) a gastrosquise está muito associada a anomalias congênitas, principalmente, à atresia das vias biliares.
- B) a onfalocèle pode estar associada à trissomia do 21 e a cardiopatias congênitas.
- C) na gastrosquise, o conteúdo herniário é recoberto por uma membrana composta por peritônio e por uma membrana amniótica.
- D) o conteúdo da gastrosquise, na maioria dos casos, é composto por fígado e intestino delgado.
- E) a onfalocèle tem sua localização, predominantemente, à direita da cicatriz umbilical.

35) Jovem de 18 anos chega ao pronto atendimento referindo dor no testículo direito de início súbito enquanto dormia. Nega febre, porém, relata estar com náuseas. À palpação, o testículo apresenta-se doloroso, elevado e horizontalizado (Sinal de Angel +). Além disso, não há melhora da dor durante a manobra de elevação do testículo (Sinal de Prehn -). Diante desse quadro, quais são a principal hipótese diagnóstica e o exame complementar mais sensível e específico?

- A) Orquiepididimite / Tomografia Computadorizada da pelve e do escroto.
- B) Torção testicular / Tomografia Computadorizada da pelve e do escroto.
- C) Torção testicular / USG escrotal com doppler colorido.
- D) Orquiepididimite / USG escrotal com doppler colorido.
- E) Síndrome de Fournier / USG perineal e escrotal com doppler colorido.

36) Assinale a alternativa correta.

- A) São classificados como materiais de síntese cirúrgica: fio, porta-agulha, pinça de Satinsky.
- B) São tipos de sutura em pontos separados: ponto simples, ponto "X" horizontal e sutura em barra grega.
- C) São classificados como fios absorvíveis: catgut, fios de polipropileno e fios de ácido polilático.
- D) A tricotomia pré-operatória deve ser, sempre que possível, realizada 24 a 48h antes do procedimento cirúrgico com intuito de prevenir a formação de foliculites ou infecção de pequenos cortes acidentais durante tal processo.
- E) Assepsia é a manobra realizada com o intuito de manter o paciente e o ambiente cirúrgico livre de patógenos.

37) Homem de 32 anos, pesando 70 quilos, durante incêndio em um canavial, foi encontrado pelo resgate com 60% da superfície corpórea queimada. Ao chegar ao pronto atendimento, ressuscitação volêmica foi logo proposta.

Qual é a solução de escolha a ser utilizada e seu volume total em 24 horas?

- A) De 8.400 ml a 16.800 ml de Ringer lactato.
- B) De 16.800 a 22.300 ml de soro fisiológico.
- C) De 8.400 ml a 16.800 ml de soro glicosado.
- D) De 4 a 8 bolsas de hemotransusão.
- E) De 3.600 a 7.400 ml de Ringer lactato.

38) Quanto ao GIST (Gastrointestinal Stromal Tumor) gástrico, é CORRETO afirmar:

- A) São oriundos das células musculares de Kulchitsky.
- B) Poucos pacientes são assintomáticos e a hemorragia digestiva alta maciça é a principal manifestação clínica inicial.
- C) Por se tratar de uma lesão epitelial, a biópsia realizada por endoscopia digestiva alta apresenta a maior positividade para o diagnóstico histológico.
- D) A linfadenectomia, durante o tratamento cirúrgico, faz-se desnecessária, pois as metástases linfonodais são raras.
- E) O tratamento cirúrgico do GIST gástrico não metastático se faz através de gastrectomia parcial, linfadenectomia e vagotomia troncular.

39) Todos os itens a seguir são complicações da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), todavia uma delas é a mais frequente. Qual é essa complicação?

- A) Fístula biliar.
- B) Perfuração do bulbo duodenal.
- C) Hemobilia.
- D) Pancreatite aguda.
- E) Sepses.

40) A respeito do aneurisma da aorta, é correto afirmar que

- A) mais de 70% dos pacientes portadores de aneurisma de aorta são sintomáticos.
- B) define-se aneurisma de aorta quando há aumento de mais de 50% do diâmetro arterial normal.
- C) os aneurismas de aorta tipo I são os mais comuns e denominados justarrenais.
- D) a USG de abdômen é o exame de escolha para o diagnóstico de ruptura de aneurisma da aorta.
- E) não há relação entre Síndrome de Marfan e o surgimento de aneurisma de aorta.

41) Recém-nascido, sexo masculino, com 18 dias de vida, estava mamando o leite de sua mãe cerca de 8 a 9 vezes por dia. Nas últimas 48 horas, mãe refere aumento na frequência de mamadas, com alguns episódios de regurgitação, mais frequentes do que nos dias anteriores. A mãe está muito cansada com a nova rotina e preocupada com a possibilidade de haver algum problema com seu leite e que seu filho ainda não está

“mamando nos horários adequados”. Nessa situação, qual a conduta mais correta?

- A) Orientar que as mamadas sejam de cerca de 20 minutos a cada 3 horas para esvaziamento adequado da mama com a fração emulsão do leite materno (leite posterior).
- B) Assegurar para a mãe que o leite materno é suficiente para esse período e prescrever bromoprida.
- C) Prescrever pequena quantidade de fórmula antirrefluxo (no máximo 30 mL) após o esvaziamento completo de cada uma das mamas.
- D) Prescrever fórmula antirrefluxo, temporariamente no período noturno (mamada da meia noite e do meio da madrugada) para a mãe poder descansar.
- E) Esclarecer que a duração pode ser de alguns dias e que o aleitamento em livre demanda deve ser mantido, pois criará uma rotina.

42) Realize a classificação antropométrica e nutricional, de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde de um escolar, com 6 anos de idade, que apresenta os seguintes dados antropométricos:

Parâmetro antropométrico	Valor absoluto	Escore z
Peso para idade	22 kg	+ 0,57
Estatura para idade	109 cm	- 1,20
Índice de massa corporal para idade	18,5 kg/m ²	+ 1,71

- A) estatura adequada para idade e eutrofia.
- B) estatura adequada para idade e sobrepeso.
- C) estatura adequada para idade e obesidade.
- D) baixa estatura para idade e eutrofia.
- E) baixa estatura para idade e risco para obesidade.

43) Adolescente, sexo masculino, com 12 anos de idade, atendido na Unidade Básica de Saúde, tem a sua situação vacinal verificada (resumo dos dados): Quais vacinas e número de doses devem ser administradas para esse adolescente, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações?

Imunizante	Número de doses e idades em que recebeu
BCG	Ao nascimento
Hepatite B	Três doses no primeiro ano de vida
Difteria / Tétano e Coqueluche	Três doses no primeiro ano, reforço com 15 meses e reforço com 6 anos de idade
Vacina contra hemófilos	Três doses no primeiro ano de vida
Vacina contra polio-mielite	5 doses nos primeiros 5 anos de vida com algumas participações em campanhas
Vacina contra sarampo, caxumba e rubéola	1 dose com 15 meses de idade e uma dose aos 4 anos de idade
Vacina contra o meningococo C	Três doses no primeiro ano de vida
Vacina de febre amarela	1 dose com 7 anos de idade

- A) Vacina contra o HPV (2 doses) e uma dose da vacina contra meningococo ACWY.
- B) Vacina contra o HPV (2 doses) e uma dose da vacina contra o meningococo C.
- C) Vacina contra o HPV (3 doses), uma dose da vacina contra o meningococo ACWY e um reforço da febre amarela.
- D) Vacina contra o HPV (3 doses), duas doses da vacina contra o meningococo C e um reforço da tríplice viral.
- E) Vacina contra o HPV (3 doses), uma dose da vacina contra o meningococo C e uma dose de vacina contra a varicela.

44) Lactente com 50 dias de vida, nascido a termo, sexo masculino, é atendido em uma unidade de pronto atendimento com preocupações da mãe sobre possibilidade de ter apresentado um episódio de febre baixa há menos de 24 horas, aferido, com valor de 37,5 graus. Criança estava agasalhada em excesso segundo informações do pai. Está em aleitamento materno exclusivo, com ótima aceitação, e a família refere que, em sua última consulta, a pediatra disse que a criança estava apresentando ganho ponderal de cerca de 30 g/dia. Devido à insistência da família, solicitou-se um hemograma com os seguintes resultados: Hemoglobina: 9,3 g/dL, Hematócrito: 29%, VCM: 98, com leuco e plaquetometria normais. Qual a conduta mais adequada a partir desse momento?

- A) Iniciar terapêutica com ferro na dose de 3 a 5 mg/kg/dia.
- B) Iniciar profilaxia com ferro na dose de 2 mg/kg/dia.
- C) Prosseguir investigação com dosagem da ferritina sérica.

- D) Prosseguir investigação com eletroforese de hemoglobina.
- E) Acompanhar clinicamente sem qualquer outro exame laboratorial ou uso medicamentoso.

45) Mãe de um adolescente, com 12 anos e 8 meses de idade, sexo masculino, apresenta preocupações com a altura de seu filho. Não há relato de nenhuma anormalidade na gestação, parto e infância. O desenvolvimento neuropsicomotor sempre foi adequado. Excelente desempenho na escola. Não há doenças crônicas. Quando tinha 11 anos e 8 meses de idade, foi atendido por um médico de família da sua região, que não encontrou nenhuma anormalidade e sua altura foi de 133 cm (percentil 1,2). Na consulta atual, exame clínico persiste sem quaisquer anormalidades, o estadiamento puberal de Tanner é G1P1 e a estatura é 137,5 cm (percentil 2). A idade óssea atual é de 11 anos. A mãe tem 163 cm, menstruou aos 15 anos e os dados puberais e estatura do pai não são conhecidos. A explicação mais provável sobre a estatura deste adolescente é

- A) um tumor da glândula hipófise.
- B) um hipotireoidismo de causa autoimune.
- C) uma baixa estatura familiar.
- D) um retardo constitucional do crescimento.
- E) um problema gonadal.

46) Criança de 5 anos é atendida em uma Unidade Básica de Saúde, trazida pela avó, bastante preocupada com a maneira de seu genro cuidar e educar a criança. Avô refere que criança é agitada e bagunceira e que, não raramente, o pai a castiga com utilização de alguns tapas e cintadas “de leve”. Refere que já identificou marcas desses castigos nas nádegas da criança. A mãe da criança também concorda com um estilo de educação mais coercitivo para a criança. Os pais são bons provedores, carinhosos a maior parte do tempo e muito preocupados com o futuro da criança. No exame físico, apenas se identifica um hematoma linear em coxa esquerda, relacionado a uma queda recente de bicicleta, segundo a opinião da avó. No que diz respeito a essa situação, assinale a afirmativa CORRETA.

- A) Uma avaliação mais detalhada da história é necessária antes de qualquer conduta, particularmente a escuta dos pais sobre esses fatos, pois, na legislação brasileira de proteção à infância, há clara distinção entre maus tratos, que devem ser repudiados e os castigos físicos disciplinares necessários para a educação infantil.
- B) A comunicação desses atos de violência contra a criança é prevista na Lei Menino Bernardo e o pediatra tem a obrigação de comunicar o fato ao Serviço Social da Unidade.
- C) Casos como o relatado devem ser cuidadosamente avaliados pelo pediatra pela possibilidade de alienação parental, em que uma avó pode estar tentando incriminar falsamente seu genro para afastamento do convívio; a avaliação psicológica é necessária.
- D) O caso deve ser comunicado ao Conselho Tutelar da região onde essa criança mora e à Secretaria Municipal de Saúde, por meio de ficha específica (notificação de agravos relacionados à violência).

E) O pediatra poderia solicitar a avaliação de um médico legista que tem mais experiência nessas situações para, em função desse laudo pericial, tomar uma atitude mais adequada diante do caso.

47) Durante o atendimento de um bebê de 6 meses, o pediatra faz uma série de orientações sobre a introdução da alimentação complementar. Assinale, das seguintes afirmações, aquela que está correta.

- A) "Não adoçar sucos e chás infantis com sacarose; apenas usar o mel".
- B) "As primeiras papas principais (almoço) deverão ser com a maior variedade possível de legumes, sem a carne".
- C) "Banana e morango não podem ser oferecidos pela alta probabilidade alergênica".
- D) "Quando o bebê rejeitar o alimento, não oferecer novamente por um período de uma semana, para que não se desenvolva uma intolerância alimentar crônica".
- E) "Iniciar a oferta de frutas tamisadas, raspadas ou amassadas".

48) Lactente de 24 meses de idade, sexo masculino, é trazido à consulta pela mãe com a queixa de que a criança, que já falava algumas palavras desde os 13 meses, deixou de falar. Você percebe que a criança não faz contato olho a olho e não responde a pequenos comandos, como para buscar algum brinquedo. Além disso, não brinca de maneira habitual com seus brinquedos. A hipótese diagnóstica mais provável é

- A) retardo mental, consequência de doença metabólica.
- B) autismo.
- C) surdez congênita.
- D) paralisia cerebral, sequela de anoxia de parto.
- E) variação do desenvolvimento normal para a idade.

49) Criança com 8 anos de idade comparece a uma consulta, após o diagnóstico de tuberculose (BAAR+++) em seu pai, que convive com HIV e que iniciou o tratamento com esquema quádruplo há 1 mês. A criança, não soropositiva, não tem tosse, não tem febre nem apresenta quaisquer outros sintomas. A criança tem uma dose de vacina BCG recebida ao nascimento. Solicitou-se uma radiografia do tórax e teste tuberculínico. Assinale a alternativa correta que relaciona os possíveis achados desses exames e suas respectivas condutas

- A) Resultado da radiografia de tórax: adenomegalia mediastinal; Resultado do teste tuberculínico: 13 mm; Conduta: tratamento de infecção latente.
- B) Resultado da radiografia de tórax: sem anormalidades; Resultado do teste tuberculínico: 7 mm; Conduta: tratamento de infecção latente.
- C) Resultado da radiografia de tórax: sem anormalidades; Resultado do teste tuberculínico: 3 mm; Conduta: alta do paciente.
- D) Resultado da radiografia de tórax: consolidação pulmonar; Resultado do teste tuberculínico: 8 mm; Conduta: repetir o teste tuberculínico.

E) Resultado da radiografia de tórax: sem anormalidades; Resultado do teste tuberculínico: 6 mm; Conduta: repetir o teste tuberculínico.

50) Bebê do sexo masculino, com 15 meses de idade, apresenta febre de 39 graus, irritabilidade e choro constante há 48 horas. Leva sua mão ao ouvido quando chora. No exame físico, estava eupneico, com hiperemia de orofaringe e, na otoscopia, apresentou abaulamento da membrana timpânica bilateral. Essa é a primeira vez que essa criança fica doente. Ainda não frequenta creche e não tem doenças de base. Além de prescrever antitérmicos, qual a conduta mais adequada?

- A) Não dar antibióticos se a criança puder ser acompanhada ambulatorialmente.
- B) Aplicar ciprofloxacino e hidrocortisona, na forma de gotas otológicas (uso tópico).
- C) Prescrever amoxicilina, na dose padrão de 45 mg/kg, por via oral.
- D) Prescrever amoxicilina, dose "dobrada" de 90 mg/kg, por via oral.
- E) Prescrever amoxicilina, dose "dobrada" de 90 mg/kg associada ao clavulanato, por via oral.

51) Escolar, com 8 anos de idade, chega ao pronto-socorro com queixa de dor de garganta e febre há 48 horas. Apresenta discreta dor abdominal e um episódio de vômito. Não apresenta tosse. No exame físico, apresenta-se afebril (medicado há 1 hora), eupneico e hidratado. Na oroscopia, apresenta hiperemia intensa, com algumas petéquias no palato e presença de exsudato purulento bilateralmente (na forma de pontos em um lado e placas, do outro). Em relação à conduta mais adequada diante da hipótese desse escolar, é correto afirmar que

- A) aplicação de penicilina benzatina por via intramuscular não é atualmente uma opção terapêutica.
- B) dose única diária de amoxicilina pode ser prescrita para o tratamento dessa condição.
- C) testes rápidos para identificação da etiologia estreptocócica não se justificam diante de quadros clínicos tão característicos de amigdalite purulenta, como na situação apresentada.
- D) antibióticos devem ser evitados nessa situação, na qual a possibilidade de infecção pelo vírus EBV é grande.
- E) não deve haver preocupação do pediatra sobre a transmissibilidade do agente envolvido nessa situação; "afastamento escolar" é desnecessário.

52) Um recém-nascido, com 11 dias de vida, iniciou quadro de febre aferida de 38,8 graus há cerca de 24 horas. Os pais referem que criança está bem, mamando sem dificuldades (aleitamento exclusivo) e que acreditam que o quadro se deve ao excesso de roupas. Durante o exame físico, observa-se temperatura de 38,2 graus após 20 minutos sem roupas, com demais dados do exame sem alterações. Qual deve ser a conduta mais adequada nesse caso?

- A) Colher hemograma, hemocultura, proteína C reativa, e urina para avaliação dos sedimentos anormais e cultura.
- B) Colher hemograma, hemocultura, proteína C reativa, e urina para avaliação dos sedimentos anormais e cultura, além de indicação de punção lombar para coleta e análise do líquido.

- C) Colher apenas urina, por saco coletor, para análise dos sedimentos anormais e cultura.
- D) Prescrever antitérmico, orientar sinais de alarme e reavaliação em 24 horas.
- E) Orientar sobre os sinais de alarme e reavaliação em 24 horas, devendo-se evitar o uso de antitérmicos para não mascarar o quadro infeccioso subjacente, se existir.

53) Lactente, com 15 meses é trazido ao pronto-socorro com quadro de diarreia (6 evacuações líquidas diárias) há 3 dias. Em relação a essa condição, assinale a afirmativa correta.

- A) Identificando-se que o lactente esteja com comprometimento perfusional, como diminuição do estado de consciência e tempo de enchimento periférico diminuído, configura-se uma desidratação grave, cuja abordagem deve iniciar-se com uma solução hipotônica de expansão.
- B) Se houver constatação de que houve perda ponderal desde o início do quadro de 7%, configura-se uma desidratação moderada, cuja abordagem terapêutica preferencialmente será com terapia de reidratação oral.
- C) Se houver relato de pelo menos dois episódios de vômito ao dia associados a um número de evacuações líquidas elevado ($> 4/\text{dia}$), a terapia de reidratação oral é formalmente contraindicada.
- D) Se o lactente se apresenta com as mucosas úmidas e coradas, turgor de pele adequado, diurese adequada, saliva fluida e abundante e perfusão periférica de 1 segundo, não há indicação de hidratação oral e prescrição de zinco.
- E) Se esse quadro clínico for associado a fezes disentéricas, febre e irritabilidade, deve-se evitar a prescrição de antibióticos como ciprofloxacina ou ceftriaxone, particularmente se a criança já frequentar creche.

54) Recém-nascido, sexo feminino, parto normal, com idade gestacional de 36 semanas e 6/7dias, peso de nascimento de 2500 g, Apgar de primeiro e quinto minutos de 7 e 9, respectivamente, está no alojamento conjunto e, com com três horas de vida, apresenta desconforto respiratório leve e tremores finos. A conduta imediata a ser tomada é

- A) realizar teste rápido de glicemia capilar.
- B) realizar gasometria arterial e radiografia de tórax.
- C) solicitar um ecocardiograma.
- D) solicitar um hemograma e hemocultura.
- E) manter observação clínica rigorosa, em cuidados intermediários, sem coleta de exames.

55) Um lactente de 1 ano estava cianótico e desacordado nos braços de sua mãe, numa via pública. Você, único profissional de saúde qualificado para iniciar um atendimento de emergência inicial no local, checa responsividade do bebê e ele não responde. Solicita ajuda e inicia, de forma sistemática, os procedimentos para a reanimação cardiopulmonar, pois o pulso e a respiração estão ausentes. Nesse caso, quais são as recomendações mais adequadas?

- A) Deve-se iniciar com as compressões torácicas, realizando-se, após, a ventilação boca a boca, em uma relação de 15 compressões para 1 ventilação.
- B) Deve-se iniciar com as compressões torácicas, que deverão ser realizadas com a técnica dos dois polegares preferencialmente para essa idade e situação apresentada, retirando-se os dedos do contato do tórax a cada movimento para evitar a exaustão do reanimador.
- C) Deve-se iniciar pela ventilação de resgate (2 ventilações boca a boca) e, após, compressões torácicas, numa relação de 15 compressões para 2 ventilações.
- D) Quando realizadas as compressões torácicas, deve-se se atentar à frequência de, no mínimo, 100 movimentos/minuto e, no máximo, 120/minuto.
- E) Após iniciada a reanimação de alta qualidade nessa faixa etária e nessa situação, as compressões não devem ser interrompidas para a instalação do desfibrilador externo automático, quando esse equipamento estiver disponível com a chegada do apoio de resgate.

56) Pré-escolar, sexo masculino, com 3 anos de idade comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de tosse e dificuldade para respirar há 3 dias. A mãe refere febre baixa apenas no início do quadro. Tem boa aceitação hídrica, embora tenha recusado algumas refeições. No exame físico, tem frequência respiratória de 50 movimentos/minuto, sem tiragem subcostal ou intercostal, sem expiração prolongada. Ausculta sem sibilos ou estertores, apenas alguns roncosp. Não há acesso a radiografias nessa Unidade. Qual é a conduta mais adequada nessa situação?

- A) Orientação de antitérmicos e hidratação oral, com retorno à UBS em 48h para reavaliação.
- B) Solicitação de hemograma e dosagem de proteína C reativa em laboratório de referência.
- C) Encaminhamento imediato ao hospital, para internação.
- D) Prescrição de amoxicilina, por via oral e acompanhamento ambulatorial.
- E) Prescrição de ceftriaxone, por via intramuscular, e encaminhamento para hospital.

57) Lactente de 20 meses apresentou uma primeira crise convulsiva tônico-clônica generalizada, com duração menor que dois minutos. Logo após a crise, o bebê ficou sonolento, e, 20 minutos depois, não apresentava mais nenhuma anormalidade. A mãe relatou coriza, obstrução nasal e tosse há cerca de dois dias. No exame físico, temperatura de 39,2 °C, frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto e frequência respiratória de 28 movimentos por minuto. A pressão arterial foi de 84 x 48 mmHg, há hiperemia acentuada da orofaringe, ausência de rigidez de nuca ou deficits neurológicos focais. A conduta mais apropriada é

- A) orientar os pais acerca da benignidade do quadro, sem introdução, nesse momento, de medicamentos anticonvulsivantes.
- B) prescrever fenobarbital como profilático para novas crises.
- C) realizar uma punção lombar para análise do líquido.
- D) internar para observação rigorosa, com antibiótico intravenoso.

E) realizar uma tomografia computadorizada de crânio.

58) Pré-escolar, sexo masculino, com 3 anos e meio, foi trazido ao serviço médico, após atendimentos por vários médicos, por conta de uma dor que tem apresentado nos membros e nas articulações, fazendo-o acordar durante a noite. Nas últimas semanas, a criança tem ficado muito cansada e apresentou alguns episódios de sangramento nasal. Durante o exame físico, identifica-se uma linfonodomegalia cervical e inguinal e hepatoesplenomegalia. Um hemograma recentemente solicitado apresenta os seguintes resultados: Hb 7,7 g/dl, Ht 23%, plaquetas 79.000/mm³, com leucometria total de 31.000/mm³. Em relação a esse caso, é CORRETO afirmar que:

- A) Dor de crescimento é o diagnóstico mais provável e os pais devem ser orientados sobre a benignidade do quadro.
- B) A anemia carencial identificada deve ser tratada e explica a sintomatologia da criança.
- C) Mononucleose infecciosa é o principal diagnóstico a ser considerado e o tratamento será realizado com sintomáticos.
- D) Corticoterapia deve ser iniciada e, dependendo da resposta clínica, possibilidade de doenças não infamatórias serão consideradas.
- E) A possibilidade de doença neoplásica é prioritária na investigação.

59) Um recém-nascido prematuro, 35 semanas, estava em apneia após a extração pelo médico obstetra em um parto expulsivo. O médico que recebeu o bebê o levou ao berço de reanimação, realizou os passos iniciais em cerca de 30 segundos e avaliou o RN que permanecia sem movimentos respiratórios e com frequência cardíaca (verificada com estetoscópio em 6 segundos) de 6 batimentos. Foram iniciadas ventilação com pressão positiva com oxigênio a 21% e monitorização da criança. Após 30 segundos de ventilação com balão e máscara, a criança ainda está em apneia, a frequência cardíaca é de 120 batimentos por minuto (monitor) e saturação de O₂ de 78%. Diante desse quadro, a próxima conduta definida pelas diretrizes atuais de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria é?

- A) Suspende a ventilação com pressão positiva, mantendo-se oxigênio inalatório devido aos valores baixos da oximetria.
- B) Manter ventilação com pressão positiva com oxigênio a 21%, procedendo-se a um estímulo tátil vigoroso do dorso do bebê e nova aspiração das vias aéreas.
- C) Manter ventilação com pressão positiva com oxigênio a 21%, checando-se a adaptação da máscara à face do RN.
- D) Aumentar a quantidade de oxigênio para 60% na ventilação com pressão positiva.
- E) Deve-se realizar intubação traqueal imediata para ventilação com oxigênio a 100%.

60) Nasce uma criança de uma gestante que teve o diagnóstico de sífilis durante a gestação, tratada com penicilina benzatina, em doses adequadas, 20 dias antes do parto. O recém-nascido (RN), termo, está assintomático, apresenta exame físico normal, VDRL sérico: não reagente; hemograma normal, radiografia de ossos longos normal e líquido com 5 células/mm³. Sua mãe apresentou VDRL com título de 1/8 (colhido pouco antes do parto).

A conduta em relação a esse RN, de acordo com o Ministério da Saúde, é

- A) acompanhamento clínico e sorológico, sem tratamento.
- B) tratamento com dose única de penicilina benzatina.
- C) tratamento com penicilina cristalina por 10 dias.
- D) tratamento com penicilina procaína por 10 dias.
- E) tratamento com penicilina procaína por 14 dias.

61) S.M.B, 40 anos, GII PIN A0, IG cronológica: 6 semanas, deu entrada no PSGO com queixa de sangramento vaginal em pequena quantidade, vermelho vivo. Ao exame ginecológico, especular: pequena quantidade de sangue coletado em fórnice posterior, sem sangramento ativo, colo uterino sem lesões. TV (toque vaginal) bimanual: colo uterino impérvio, FU (fundo uterino) intrapélvico. DB negativo, anexos não palpáveis. TS Rh positivo. Submetida à USG (ultrassonografia) transvaginal, que demonstrou: SG intrauterino, com diâmetro médio de 9 mm, não identificados embrião ou vesícula vitelínica. Diante do caso, assinale a alternativa correta.

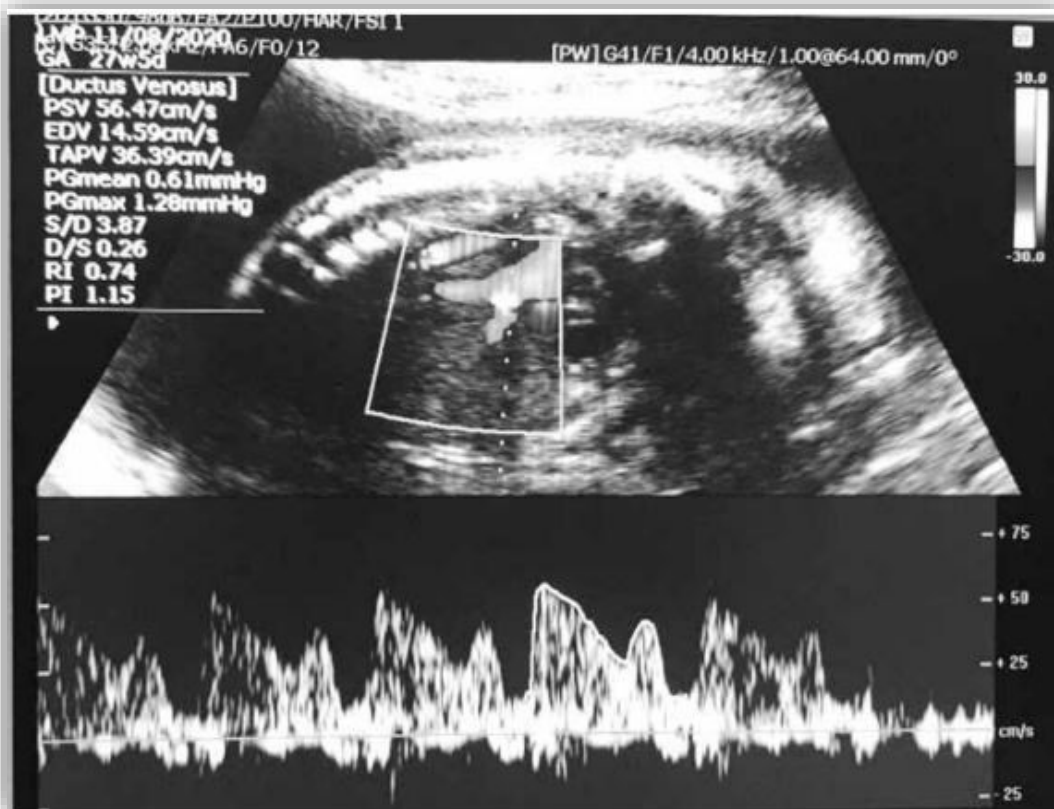
- A) Trata-se de aborto em curso, devendo-se tomar conduta expectante.
- B) Trata-se de aborto em curso, devendo-se internar a paciente para conduta ativa como AMIU.
- C) Trata-se de ameaça de aborto, devendo-se administrar imunoglobulina anti-D.
- D) Trata-se de ameaça de aborto, devendo-se repetir USG em 10-14 dias.
- E) Trata-se de aborto incompleto, devendo-se investigar, também, gestação heterotópica.

62) R.N.B., 36 anos, GII PI 1C (há 5 anos) A0, IG usg: 40 semanas, com hipotireoidismo, IMC: 46 kg/m² e DMG (diabetes mellitus gestacional). Avaliação da vitalidade fetal: cardiotocografia: normal. Internada para indução do parto com balão de Krause. Balão é eliminado 2 horas após inserção. TV: 5 cm, M, posterior, apresentação cefálica, -2 De Lee. Tônus uterino de difícil avaliação por tecido adiposo espesso. Introduzida ocitocina em BIC para continuação da indução do trabalho de parto até 72 mL/h. Plantonista é solicitada no pré-parto, pois paciente refere bastante dor. Reavaliação: TV – não se identifica apresentação fetal. Evidenciado sangramento vaginal. Não identificados BCF ao sonar. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conduta imediata e a provável hipótese diagnóstica.

- A) Solicitar ultrassonografia obstétrica para avaliar foco cardíaco fetal e placenta; placenta prévia.
- B) Cesariana de emergência; rotura de vasa prévia.
- C) Cesariana de emergência; rotura uterina.
- D) Aminiocotomia artificial; descolamento prematuro de placenta.
- E) Cesariana de urgência; laceração do colo uterino pelo balão de Krause.

63) L.G.B., 32 anos, GII PI 1N A0, IG usg: 32 semanas e 3 dias, internada por descontrole pressórico ambulatorial. Em uso de metildopa 1,5 g por dia. PA (pressão arterial): 150 x 90 mmHg, assintomática. Realizada rotina pré-eclâmpsia: normal, exceto por relação proteína

na urina (mg dL)/creatinina na urina (mg/dL): 0,4. Submetida à Ultrassonografia Obstétrica com doppler que evidenciou peso fetal no percentil 1,5, de acordo com a curva de Hadlock, apresentação cefálica, placenta posterior grau II de Grannum, MBV: 3,2 cm; doppler de artéria umbilical com diástole zero e ducto venoso com IP 1,15. Diante do caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.



- A) Administrar sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, controle de PA e controle diário da vitalidade fetal com IP do ducto venoso.
- B) Administrar sulfato de magnésio para neuroproteção fetal e para prevenção de eclâmpsia, corticoterapia e controle diário da vitalidade fetal com cardiotocografia e perfil biofísico fetal.
- C) Corticoterapia para maturação pulmonar fetal, sulfato de magnésio para prevenção de eclâmpsia, controle da PA e indução do parto.
- D) Corticoterapia para maturação pulmonar fetal, controle da PA e controle da vitalidade fetal com IP do ducto venoso a cada 3 dias.
- E) Corticoterapia para maturação pulmonar fetal, controle de PA e interrupção da gestação por via alta.

64) Um curso de corticosteroide pode diminuir o risco da Síndrome da Angústia Respiratória do recém-nascido, melhorar a estabilidade circulatória, com menores taxas de hemorragia intraventricular, enterocolite necrosante e infecção sistêmica nas primeiras 48 horas de vida. Com relação a esse tratamento, para acelerar a maturação pulmonar fetal, assinale a alternativa correta.

- A) Dose de resgate é contraindicada pelo risco aumentado de RCIU (restrição de crescimento intrauterino).
- B) A corticoterapia pode levar à hiperglicemia transitória.
- C) Pela sua alta atividade mineralocorticoide, causa aumento dos níveis pressóricos e, por isso, deve ser evitada nas gestantes com síndrome hipertensiva.
- D) Nas pacientes com pré-eclampsia grave, deve ser evitada, em decorrência da urgência na necessidade da interrupção da gestação.
- E) Se administrado com menos de 23 semanas, aumenta a sobrevivência, não causando comprometimentos graves ao feto.

65) A Hemorragia Pós-Parto (HPP) é tradicionalmente definida como a perda acima de 500 ml de sangue após o parto vaginal ou acima de 1.000 ml após o parto cesáreo, e a HPP é considerada grave quando a perda de sangue excede 1.000 ml após o parto vaginal ou resulta em sinais e sintomas de instabilidade hemodinâmica. Com relação às várias medidas preventivas da atonia uterina, que é a principal causa de HPP, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O uso de metilergonovina durante o trabalho de parto.
- B) O uso de antibiótico após o clameamento do cordão umbilical.
- C) O uso de misoprostol 1.000 mcg VR após o quarto período do parto.
- D) O uso de ocitocina no terceiro período do parto.
- E) O uso de terbutalina no segundo período do parto.

66) P.G.B., 28 anos, GIV PII 2N AI; IG usg: 38 semanas, deu entrada no PSGO com carta da UBS (unidade básica de saúde) solicitando avaliação em razão de a ultrassonografia obstétrica apresentar MBV (maior bolsão vertical): 1,9 cm. Peso fetal normal; doppler de artérias umbilicais: normal, placenta fúndica GII. Paciente nega perdas vaginais. Sem outras queixas. Nega comorbidades. Cardiotocografia: normal. De acordo com o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta diagnóstico e conduta corretos.

- A) Oligoâmnio; internação da paciente e indução do trabalho de parto.
- B) Oligoâmnio; usg a cada 3 dias para acompanhar ILA (índice de líquido amniótico) e vitalidade fetal e interrupção da gestação com IG 39 semanas.
- C) Oligoâmnio; usg semanal para acompanhar ILA e vitalidade fetal e interrupção da gestação com IG 40 semanas.
- D) Não se consegue avaliar normalidade do líquido amniótico apenas pelo MBV; realizar novo usg para medir o ILA.
- E) O ILA provavelmente está normal; alta com retorno 3/3 dias para avaliação da vitalidade fetal por cardiotocografia.

67) O fígado gorduroso agudo da gravidez (FGAG) é a principal causa de insuficiência hepática aguda e encefalopatia durante a gestação. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

- A) Ocorre tipicamente no primeiro trimestre da gestação.
- B) Trata-se de uma doença com baixas mortalidades materna e fetal.
- C) É uma doença hepática gestacional relativamente comum.
- D) Os fatores de risco mais relevantes são primiparidade e gestação gemelar.
- E) A biópsia hepática é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de FGAG.

68) G.M.D., 30 anos GIV PIII (2N 1C) A0, IG usg: 21 semanas, veio ao serviço de medicina fetal para ultrassom (usg) morfológico de 2º trimestre. Identificada morfologia do feto normal. Ao usg transvaginal: medida do colo uterino 15 mm, presença do sinal do afunilamento, presença de sludge, ausência do eco glandular endocervical (EGE). Nega perdas vaginais, nega dor tipo contração uterina, nega febre ou disúria ou leucorreia. Paciente com antecedente de 2 trabalhos de partos prematuros, com 32 e 33 semanas, respectivamente. Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que contém a conduta correta.

- A) Prescrever progesterona via vaginal.
- B) Conduta expectante, uma vez que ela não possui histórico de perdas no segundo trimestre da gestação.
- C) Tratar o sludge com antibioticoterapia, realizar culturas de secreção vaginal e programar cerclagem uterina.
- D) Prescrever corticoide e avaliar uso de pessário cervical.
- E) Repetir usg com ig 30 semanas e, se colo uterino < 20 mm, avaliar uso de pessário.

69) R.L.T., 36 anos, GIII PI 1N AI, IG 31 semanas, internada na patologia obstétrica para controle pressórico. Diagnóstico de pré-eclâmpsia. Em uso de metildopa 2g/dia e anlodipino 10 mg/dia. USG obstétrico recente: peso fetal no percentil 4, BCF presente, ILA normal. No plantão noturno, identificada PA 150 x 100 mmHg, sem sinais de iminência de eclâmpsia e tônus uterino aumentado. Paciente queixando-se de dor abdominal persistente. Batimentos cardíacos não identificados ao sonar. Não há USG à noite no serviço. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável e a conduta adequada.

- A) Dor por sangramento oculto de placenta prévia; corticoterapia e programar interrupção da gestação via alta.
- B) Trabalho de parto prematuro (TPP); nifedipino para inibir TPP, já que paciente é hipertensa.
- C) Rotura uterina; cesariana de urgência.
- D) Corioamnionite; investigar sinais de infecção por exames laboratoriais.
- E) Descolamento prematuro de placenta com sangramento oculto; cesariana de emergência.

70) As gestações gemelares requerem atenção especial, pois contribuem de forma significativa para o aumento das complicações perinatais; parte dessas complicações são atribuídas a distúrbios do crescimento de um ou de ambos os fetos. A respeito das gestações

múltiplas, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Nas gestações gemelares dicoriônicas com óbito de um feto, a principal complicação para o feto vivo é o risco de morte ou de sequela neurológica.
- B) Nas gestações gemelares monocoriônicas com óbito de um feto, a principal complicação para o feto vivo é o parto prematuro.
- C) STFF (Síndrome de Transfusão Feto Fetal), sequência de perfusão arterial reversa com feto acárdico e gemelaridade imperfeita são complicações da gestação gemelar dicoriônica.
- D) Nas gestações gemelares monocoriônicas, os fetos geralmente ocupam cavidades amnióticas diferentes, mas podem ocupar a mesma bolsa amniótica.
- E) O sinal do lambda indica gestação gemelar com mais de 1 âmnio, e o sinal do T indica gestação gemelar com mais de 1 córion.

71) M.V.C., 42 anos, nuligesta, com ciclos menstruais longos (45-90/7-10 dias) até os 38 anos, que foram regularizados depois. Tentando gestar há 2 anos, sem êxito. Exames do parceiro sem alterações. Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para essa paciente.

- A) Indução da ovulação.
- B) Coito programado.
- C) Fertilização in vitro (FIV).
- D) Solicitar ovodocção.
- E) Expectante.

72) Os pólipos endometriais são lesões confinadas à cavidade uterina, que apresentam comportamento distinto, de acordo com suas características histológicas. Sua prevalência está relacionada a algumas comorbidades. Assinale a alternativa que demonstra fatores de risco para o surgimento desses pólipos.

- A) Menopausa precoce, obesidade, antagonistas de estrogênio.
- B) HAS, menopausa precoce e uso de progesterona.
- C) Diabetes mellitus, obesidade e menopausa precoce.
- D) Menopausa tardia, HAS, agonistas de estrogênio.
- E) multiparidade, uso de agonistas de GnRH, menopausa tardia.

73) M.F.F., 50 anos de idade, relata sintomas vasomotores de forte intensidade há 8 meses. Apresenta FSH 50 mUI/mL. Refere ser hysterectomizada há 9 anos e informa que a mãe teve fratura por osteoporose e infarto agudo do miocárdio. Alega temor ao câncer mamário. Nega antecedente familiar com câncer de mama. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o fármaco recomendado para a paciente acima.

- A) Progestagênio.
- B) Raloxifeno.
- C) Estrogênio.

- D) Tamoxifeno.
- E) Análogo de GnRH.

74) P.M.R., 28 anos, nuligesta, deu entrada no PS ginecológico com dor pélvica de início súbito. DUM há cerca de 14 dias, MAC: condom uso regular. Ao exame físico, abdome: flácido, DB negativo, dor à palpação profunda de FIE. Sinal de Murphy negativo, Giordano negativo. TV: colo uterino indolor à mobilização. Submetida à ultrassom transvaginal (USG) que demonstrou: imagem em ovário E com eco em suspensão do tipo hemorrágico (reticulado), medindo 4,6 cm de diâmetro. Útero e ovário D sem alterações. Beta-hCG negativo; Hb 12,0 g/dl. De acordo com esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável e a conduta CORRETA.

- A) Cisto de corpo lúteo hemorrágico; laparoscopia para ooforopastia.
- B) Endometrioma; laparoscopia para ooforoplastia.
- C) Aborto tubáreo; conduta expectante.
- D) Cisto de corpo lúteo hemorrágico; repetir USG em 2 semanas.
- E) Endometrioma; conduta expectante e orientar repouso relativo.

75) A infecção pelo HPV é universal no trato genital feminino, podendo comprometer tanto a pele como as mucosas, causando uma série de manifestações nosológicas importantes, entre elas as verrugas genitais, as neoplasias intraepiteliais e os cânceres. A Organização Mundial da Saúde emitiu chamado em 2018 para eliminação do câncer de colo uterino como um grave problema de saúde pública. Considerando as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo Uterino (Ministério da Saúde – MS), assinale a alternativa CORRETA quanto à população-alvo para o rastreio e/ou à periodicidade em que ele deve ser feito.

- A) A partir dos 20 anos de idade para as mulheres que já iniciaram a vida sexual.
- B) O rastreio deve ser feito até os 70 anos de idade.
- C) Mulheres > 64 anos de idade que nunca se submeteram ao rastreio não precisam ser mais submetidas a exames.
- D) Em mulheres imunossuprimidas, devem ser realizados após o início da atividade sexual, com intervalos semestrais nos primeiros 2 anos.
- E) A periodicidade recomendada de rastreio é trienal, após 2 exames negativos com intervalo de 1 ano.

76) O tema de imunizações na pré-concepção, na gestação e no puerpério deve ser abordado nas consultas de ginecologia, obstetrícia e pediatria, uma vez que ainda há baixas taxas de adesão à vacinação pré-natal, especialmente entre gestantes com baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, alguns grupos raciais e étnicos e comportamentos alternativos. Com relação à vacinação e gestação/puerpério, assinale a alternativa correta.

- A) A vacina HPV pode ser indicada na gestação.
- B) Vacina tríplice viral (SCR) é contraindicada na gestação e no puerpério.

- C) Gestantes susceptíveis à hepatite B devem receber a vacina contra a Hepatite B.
- D) A vacina dTpa (tríplice bacteriana acelular) só deve ser aplicada após a 30ª semana de gestação.
- E) Não é necessária a vacinação com dTpa em todos aqueles que convivem com o lactente jovem.

77) Mulher de 36 anos de idade, GIII PII 2N AI, de prole constituída, refere sua história familiar: pai faleceu por câncer de próstata aos 45 anos; tia paterna faleceu por câncer de mama aos 38 anos; avó paterna faleceu por câncer de ovário aos 65 anos. Refere que seu pai possui teste genético com mutação patogênica no gene BRCA1. Paciente demonstra preocupação e manifesta desejo de realizar mastectomia redutora de risco por receio de desenvolver CA de mama. Assinale a alternativa que apresenta a melhor abordagem para esse caso clínico.

- A) Oferecer Tamoxifeno ou Raloxifeno como quimioprevenção.
- B) Oferecer o teste genético para a pesquisa de BRCA1, explicando que o risco de ela ter herdado a mutação do pai é de 50%.
- C) Recomendar a salpingooforectomia redutora de risco para reduzir a mortalidade por câncer de ovário e o risco de câncer de mama.
- D) Tranquilizar a paciente, pois ela não corre riscos de apresentar a mutação identificada na linhagem paterna.
- E) Contraindicar a mastectomia redutora de risco, uma vez que ela diminui risco de câncer de mama em torno de apenas 20%.

78) Mulher de 48 anos, com metrorragia, procurou consultório ginecológico para tratamento. Solicitado usg (ultrassom) transvaginal: sem alterações; papanicolaou: normal. Beta HCG negativo. Ao exame ginecológico, especular: colo uterino sem lesões. Conteúdo vaginal fisiológico. TV (toque vaginal) bimanual: colo indolor à mobilização. Fundo uterino intrapélvico, anexos não palpáveis. Nega outras comorbidades. MAC: condon de uso regular. Diante desse caso, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o diagnóstico e a conduta inicial.

- A) Sangramento uterino disfuncional; combinado estroprogestínico.
- B) Miomatose uterina; DIU levonorgestrel.
- C) Pólipo endocervical; histeroscopia cirúrgica.
- D) Endometriose; DIU levonorgestrel.
- E) Pólipo endometrial; acetato de medroxiprogesterona 10mg/dia por 10 dias.

79) O tratamento da úlcera genital feminina tem como base a clínica das lesões e a prevalência local dos agentes etiológicos. Desse modo, o fluxograma para abordagem sindrômica de úlceras genitais femininas, preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), orienta, inicialmente, a anamnese e o exame físico. Com base no fluxograma, em uma paciente em que a úlcera não tenha padrão vesiculoso e tenha poucos dias de evolução, assinale a alternativa que apresenta a(s) doença(s) a ser(em) tratada(s) primeiramente.

- A) Sífilis secundária.
- B) Cancro mole e donovanose.
- C) Sífilis e cancro mole.
- D) Herpes genital e donovanose.
- E) Donovanose e sífilis.

80) K.M.B., 16 anos, usuária de drogas e tabagista, 20 cigarros/dia, puérpera no terceiro dia pós-parto vaginal. Equipe da neonatologia permitiu que ela amamentasse após resultado de exame toxicológico de sangue negativo. Sem outras comorbidades. Mãe da paciente e paciente solicitam à equipe médica um método anticoncepcional. Assinale a alternativa que apresenta o método adequado para esse caso.

- A) Pílula combinada oral.
- B) Implante com etonogestrel.
- C) Anel vaginal com etonogestrel e etinilestradiol.
- D) Adesivo com norelgestromina e etinilestradiol.
- E) DIU de cobre.

81) Assinale a alternativa correta sobre a vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) – vacina HPV.

- A) Trata-se de uma vacina contraindicada para pessoas vivendo com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos.
- B) A vacina não substitui o rastreamento do câncer e não confere proteção contra todos os subtipos oncogênicos de HPV.
- C) Deve-se evitar a administração simultânea da vacina HPV com outras do Calendário Nacional de Vacinação do Plano Nacional de Imunização.
- D) Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a vacinação de adolescentes do sexo feminino ocorrerá somente com autorização ou acompanhamento dos pais ou responsáveis.
- E) A vacina é destinada à utilização preventiva e tem efeito demonstrado ainda nas infecções pré-existentes ou na doença clínica estabelecida.

82) Uma mulher de 23 anos de idade fez o pré-natal do seu primeiro filho em uma UBS. Após o parto, ela comparece para as consultas de puericultura. Mora com o filho de 6 meses e com o companheiro de mesma idade, que trabalha como segurança de um shopping. A equipe de saúde percebe que ela está mais quieta, triste e nota que, com certa frequência, apresenta hematomas nos braços. Assinale a alternativa correta em relação a esse caso.

- A) A equipe de saúde deve aventar a possibilidade de violência doméstica e planejar uma forma de abordagem para investigar o caso.
- B) A equipe de saúde deve encaminhá-la ao médico da UBS para que ele peça exames de coagulação.
- C) É pouco provável que seja um caso de violência doméstica, pois esclarecimentos que a mídia tem dado à população têm resultado em diminuição de casos entre os jovens.

D) Em geral, a violência doméstica ocorre contra a mulher e os filhos e, como não há indícios de violência contra a criança, a equipe de saúde deve apenas manter observação.

E) A equipe de saúde deve convocar o companheiro da jovem para confrontação e, caso ele confesse a prática de violência, deve ser repreendido na frente da mulher.

83) Uma unidade de urgência de um pequeno município atende, em um certo dia, 4 casos. Um deles é o de uma mulher ferida, acompanhada da irmã, que diz que ela apanhou do marido, o que é negado pela vítima. O segundo caso é o de um jovem com picada de cobra. O terceiro caso é o de um trabalhador rural que sofreu uma fratura de perna ao cair do caminhão que o levava ao trabalho na zona rural. O quarto caso é o de um sepultador que vinha tendo dor no punho direito principalmente nas aberturas e fechamentos das covas, feitos manualmente, com piora no último dia. Assinale a alternativa correta no tocante à notificação no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).

A) Apenas o caso do sepultador deve ser notificado, pois se trata de um trabalhador formal.

B) O caso do trabalhador rural deve ser notificado se ele tiver registro em carteira.

C) Nenhum dos casos deve ser notificado, pois não se trata de doenças com alta gravidade.

D) Todos os casos devem ser notificados.

E) Apenas os casos do trabalhador rural e do sepultador devem ser notificados.

84) Assinale a alternativa correta em relação às semanas epidemiológicas.

A) Devem sempre coincidir com o calendário.

B) Atualmente não têm aplicabilidade.

C) Começam no domingo e terminam no sábado.

D) Permitem comparações somente dentro do país, já que a padronização é nacional.

E) Diferentemente de uma semana do calendário, têm a duração de 10 dias.

85) Um paciente procura uma unidade de urgência, pois está com diarreia há um dia e em seu prontuário é classificado pela cor verde. Pergunta do que se trata e um dos profissionais da equipe de saúde lhe diz que se trata da classificação de risco. Nesse caso,

A) o paciente foi classificado como de risco médio e deverá ser atendido imediatamente.

B) o paciente foi classificado como de baixo risco e deverá ser encaminhado a uma consulta na UBS.

C) o paciente foi classificado como de baixo risco e deverá ser encaminhado a uma consulta na unidade ambulatorial especializada.

D) a classificação foi equivocada.

E) o paciente foi classificado como de baixo risco e deverá aguardar para ser atendido.

86) O coeficiente de ataque

A) é calculado considerando o número de mortes.

- B) serve para investigar surtos epidêmicos logo que surgem e durante a sua vigência.
- C) é útil somente em casos em que o período de incubação é longo.
- D) é um indicador de gravidade.
- E) é um indicador de transmissibilidade.

87) Assinale a alternativa correta sobre o câncer de colo do útero.

- A) Gestantes estão protegidas do câncer do colo do útero ou de lesões precursoras.
- B) O rastreamento em mulheres com menos de 25 anos tem impacto na redução da incidência e/ou mortalidade por câncer do colo do útero.
- C) A detecção das lesões precursoras do câncer do colo do útero continua sendo muito útil.
- D) As mulheres que tomaram vacina HPV na época correta não têm câncer de colo do útero.
- E) É importante que se faça o exame citopatológico anualmente até os 75 anos de idade.

88) Assinale a alternativa que contém um aspecto que dificulta o controle da disseminação do SARS-CoV-2 e da Covid-19.

- A) O vírus é transmitido por contato com superfícies contaminadas.
- B) O vírus é transmitido por via aérea.
- C) Há um grande percentual de casos graves.
- D) A doença tem alto coeficiente de mortalidade específica.
- E) O coeficiente de letalidade pela doença é alto.

89) Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a Constituição Federal.

- A) Fiscalizar os ambientes de trabalho com base nas leis trabalhistas.
- B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, da educação, da assistência e previdência social.
- C) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para quaisquer finalidades.
- D) Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- E) Atuar na proteção do meio ambiente, fiscalizando os mananciais.

90) No caso da Covid-19, assinale a alternativa correta.

- A) A Covid-19 é uma doença sistêmica que atinge vários órgãos.
- B) As pessoas com suspeita de Covid-19 devem permanecer em casa e procurar uma unidade de saúde se tiverem falta de ar.
- C) Inexistem estudos conclusivos quanto ao benefício das vacinas.
- D) As unidades de urgência não devem ser procuradas por sua estrutura inadequada para fazer uma investigação adequada.

E) Os sintomas e quadros clínicos da Covid-19 de longa duração são irreversíveis.

91) O complexo econômico industrial da saúde

A) foi um conceito criado no início da pandemia da Covid-19 quando o Brasil se deu conta de que sequer tinha máscaras fabricadas em território nacional.

B) é viável em países em que a saúde seja prioritariamente do setor privado.

C) foi planejado restringindo-se a medicamentos que representam atualmente o maior gasto da União.

D) é incompatível com a Constituição Federal, que veda a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

E) foi designado como um dos setores prioritários para o desenvolvimento nacional, no âmbito do Plano Brasil Maior, lançado em 2011.

92) A morte materna tardia

A) refere-se à morte prematura de uma gestante com impacto profundo no indicador anos potenciais de vida perdidos.

B) é a morte de uma mulher por doenças que existiam antes da gestação ou que se desenvolveram durante esse período.

C) é a morte de uma mulher durante a gestação ou até 2 anos após o término da gestação de mais de 6 meses.

D) refere-se à morte de uma mulher por causas obstétricas diretas ou indiretas, que ocorre num período superior a 42 dias e inferior a um ano após o término da gravidez.

E) tem aumentado muito no Brasil sobretudo pela majoração de mortes por causas externas em decorrência de situações de violência.

93) Assinale a alternativa correta sobre o câncer de mama.

A) A prevenção é relativamente fácil de se fazer.

B) O maior fator de risco para a ocorrência da doença é o consumo de bebida alcoólica.

C) A amamentação é um fator de proteção.

D) A terapia de reposição hormonal (TRH) é um fator de proteção.

E) Trata-se de doença genética e inexistem ações que possam prevenir sua ocorrência.

94) A atenção primária da saúde (APS) é fundamental na promoção de saúde e na prevenção de doenças com alta prevalência na população adulta. Assinale a alternativa correta no tocante à hipertensão arterial.

A) Para o tratamento do idoso hipertenso, além da estratificação de risco, é fundamental a avaliação de comorbidades e uso de medicamentos.

B) A hipertensão arterial em crianças e adolescentes não é problema de saúde pública e deve ser monitorada anualmente para pessoas a partir dos 25 anos de idade.

- C) O aparecimento de hipertensão arterial durante o uso de anticoncepcional oral exige a introdução de anti-hipertensivos como primeira medida a ser tomada.
- D) A prática de atividade física regular é uma medida que contribui para a promoção da saúde, mas não atua como um dos elementos de prevenção de hipertensão arterial.
- E) Em hipertensos com doença arterial coronariana, objetiva-se o controle imediato da pressão arterial até atingir níveis inferiores a 110/70 mmHg.

95) Em um pequeno município, o secretário de saúde elege como uma das medidas prioritárias, juntamente com outras secretarias da prefeitura, promover articulação intersetorial no âmbito dos conselhos de segurança alimentar, para que o crédito e o financiamento da agricultura familiar incorpore ações de fomento à produção de frutas, legumes e verduras visando ao incremento da oferta e ao consequente aumento do consumo desses alimentos no município. Ao mesmo tempo, participa ativamente da articulação da gestão com escolas públicas e privadas para que planejem ações que favoreçam o acesso à alimentação saudável e o estímulo ao consumo de alimentos não processados. Assinale a alternativa correta.

- A) A secretaria de saúde deveria prover os munícipes de serviços de saúde com alta resolutividade antes de empreender esforços que dão resultados duvidosos a longo prazo.
- B) A agricultura familiar não consegue prover alimentação para a população de um município, mesmo pequeno, e assim, essas medidas não contribuem para a promoção da saúde.
- C) As ações descritas fazem parte da Política Nacional de Promoção da Saúde e é importante que façam parte das gestões municipais.
- D) Cada secretaria deveria tratar de ações específicas de sua pasta para que o planejamento das ações setoriais não perca o foco prioritário.
- E) As ações descritas têm poucas chances de êxito, pois a sociedade brasileira, em geral, prefere alimentos industrializados aos naturais.

96) Após muito ouvir sua mãe, conselheira de saúde de um pequeno município, um jovem de 22 anos procura a UBS para uma avaliação de sua saúde. Sente-se saudável. É obeso, sedentário e se alimenta com muitos produtos industrializados. Seu pai, de 50 anos de idade, é hipertenso e diabético. Considerando essa situação, assinale a alternativa correta.

- A) O excesso de peso, o antecedente familiar e a inatividade física são critérios para o rastreamento do diabetes mellitus a despeito de ser assintomático.
- B) Qualquer exame no momento da primeira avaliação seria inútil, pois o jovem tem várias características que devem ser alteradas antes.
- C) Por ser assintomático, o rastreamento para o diabetes mellitus não é indicado e ele deve receber orientações da enfermagem para que altere seu estilo de vida.
- D) Apesar de características do seu estilo de vida, o aspecto da idade é um fator de proteção, pois sabe-se que o diabetes mellitus tipo 2 ocorre após os 30 anos de idade.

E) Pelas características do caso, o jovem deve ser encaminhado a um ambulatório de especialidade pois a UBS não dispõe de recursos para avaliar a sua saúde.

97) Um exemplo de estudo seccional foi desenvolvido em determinada cidade para identificar fatores sociodemográficos associados à depressão. Verificou-se que os episódios depressivos estavam relacionados preponderantemente ao sexo feminino, aos mais velhos e aos que não estavam trabalhando. Com base no enunciado, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de um estudo que não tem valor para planejamento de ações de saúde.
- B) Trata-se de um estudo de alto custo.
- C) Esse estudo pode determinar a incidência de depressão na população estudada.
- D) Esse estudo mostra que o desemprego aumenta a possibilidade de se ter depressão.
- E) Esse estudo pode determinar a prevalência de depressão na população estudada.

98) Na epidemia, por fonte comum:

- A) Todos os afetados devem ter tido acesso direto ao veículo disseminador da doença, não necessariamente ao mesmo tempo nem no mesmo lugar.
- B) É importante que a cadeia de propagação de doença pessoa a pessoa seja interrompida.
- C) Todos os afetados devem ter tido acesso direto à fonte de propagação do agente infectante, portanto a um mesmo lugar.
- D) A doença é altamente transmissível e um dos exemplos emblemáticos é a covid-19, cuja fonte inicial localiza-se na China.
- E) Os casos sempre ocorrem em um curto espaço de tempo.

99) Assinale a alternativa que contenha um dos objetivos da assistência social, conforme Constituição Federal.

- A) A integração de pessoas com deficiência a comunidades especiais.
- B) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal a todas pessoas com deficiência.
- C) O amparo às crianças e adolescentes órfãos.
- D) A garantia de um salário mínimo de benefício mensal a todos os idosos.
- E) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice.

100) Sobre a estratégia Consultório na Rua, assinale a alternativa correta.

- A) As equipes dos consultórios na rua abordam temas como o uso abusivo de álcool, crack e outras drogas, fornecendo informações e dando aulas sobre agravos relacionados a esse hábito a pessoas em situação de rua.
- B) Para ser acolhido no consultório na rua, o usuário deve fornecer pelo menos um endereço de referência, mesmo que não seja de parentes, e tem que ter pelo menos um documento de identidade.

C) O consultório na rua é formado por equipes multiprofissionais que realizam suas atividades de forma itinerante, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e ao Sistema Único de Assistência Social, sem relação com as UBS.

D) Instituída em 2011, visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados.

E) O consultório na rua é formado por equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde frente às necessidades da população em situação de rua, com preparo especial para lidar com violência física que caracteriza a abordagem a esse segmento social.

GABARITO

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
E	D	D	A	E	B	D	C	B	E
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
B	A	B	D	B	B	C	D	A	D
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
C	C	D	A	A	B	E	C	D	C
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
C	D	A	B	E	A	B	D	C	A
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
D	B	C	C	D	D	D	E	D	C
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
D	D	A	E	D	D	A	C	E	A
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
C	A	E	A	E	A	X	B	C	E
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
B	C	A	D	B	E	C	A	B	A
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
E	D	B	D	B	C	E	C	D	E
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
E	A	C	B	C	B	D	B	A	D